

# 아급성 갑상선염, 이해하고 끝까지 치료하기

바이러스 감염 후 갑상선에 생기는 통증성 염증 — 4단계 자연경과와 단계별 치료법을  
알아봅니다

# 아급성 갑상선염 (Subacute Thyroiditis, de Quervain's)

바이러스 감염 후 2~8주 뒤 발생하는 자기 한정적 갑상선 염증 — 성인 갑상선 통증의 가장 흔한 원인



환자가 경부 통증을 경험



30~50세 여성에게 호발



12~18개월 내 완전 회복

감기 등 바이러스 감염 후 2~8주 뒤 갑상선에 염증이 시작됩니다. 여름~초가을(엔테로바이러스 유행기)에 더 흔하며, 대부분 자기 한정적이지만 5~15%에서 영구적 갑상선기능저하증이 남을 수 있어 적절한 치료와 경과 관찰이 필요합니다.

# 왜 생길까요? — 바이러스 감염이 방아쇠

바이러스가 직접 갑상선을 공격하거나, 면역 반응이 과도하게 활성화되어 갑상선 세포가 파괴됩니다

## 감기 등 바이러스 감염 후 2~8주 뒤에 갑상선에 통증과 염증이 시작됩니다.

콕사키 바이러스(Coxsackie), 아데노바이러스, 볼거리 바이러스(mumps), EBV, 코로나19 등 다양한 바이러스가 원인이 됩니다. 바이러스가 갑상선 여포 세포를 직접 손상시키거나, 면역 반응이 과도하게 활성화되어 여포가 파괴됩니다. 파괴된 세포에서 저장돼 있던 갑상선 호르몬이 한꺼번에 혈중으로 유출되면서 갑상선중독 증상이 나타납니다.



### GENETIC SUSCEPTIBILITY

#### HLA-B\*35 양성

환자의 약 70%에서 이 유전자 표지가 양성 — 가족 중 갑상선 질환력이 있다면 주의가 필요합니다.

### SEASONAL PATTERN

#### 여름~초가을

엔테로바이러스 유행기와 일치 — 코로나19 이후 발생 빈도가 증가했다는 보고도 있습니다.

# 주요 증상 — 4가지 핵심 신호

환자의 96%가 경부 통증을 경험하며, 약 50%에서 갑상선중독 증상이 동반됩니다

## SYMPTOM · 01 · 96%

### 목 앞쪽 통증 (Neck Pain)

갑상선 부위(목 앞쪽)에 심한 통증과 압통. 턱·귀·뒷머리로 방사되며, 한쪽에서 시작해 반대쪽으로 옮겨가기도 합니다. 삼킬 때 통증이 심해질 수 있습니다.

## SYMPTOM · 02

### 발열과 전신 증상 (Fever)

38~40도의 발열, 몸살, 피로감이 동반됩니다. 감기 후에 시작되므로 처음에는 감기가 계속되는 것으로 오해하기 쉽습니다.

## SYMPTOM · 03 · 50%

### 갑상선중독 증상 (Thyrotoxicosis)

갑상선 세포 파괴로 저장된 호르몬이 한꺼번에 유출되어 빈맥(심장 빨리 뛸), 손 떨림, 체중 감소, 더위를 잘 타는 증상이 나타납니다.

## SYMPTOM · 04

### 갑상선 종대 (Goiter)

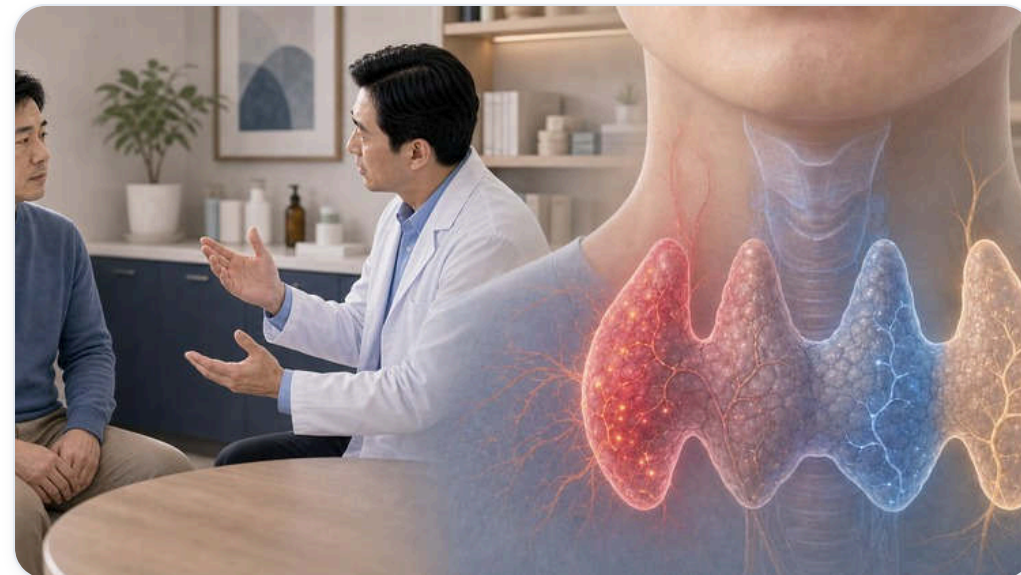
목 앞쪽 갑상선이 커지고 만지면 단단하고 아픕니다. 한쪽 엽이 다른 쪽보다 더 부어 보이기도 합니다. 림프절은 보통 정상입니다.

# 자연경과 — 4단계 패턴

대부분 6~18개월에 걸쳐 단계적으로 회복됩니다 (Hyperthyroid → Euthyroid → Hypothyroid → Recovery)



**참고** 3단계를 모두 거치는 환자는 약 30%이며, 중독기만 거치고 바로 회복하는 경우도 많습니다. 영구적 기능저하(5~15%)는 정기 검사로 조기 발견하면 호르몬 보충으로 정상 생활이 가능합니다.



# 진단은 어떻게 하나요?

혈액검사(ESR/CRP·갑상선 기능)와 영상검사(초음파·RAIU)를 종합하여 진단합니다

## LAB · 01

### 염증 수치 (ESR / CRP)

ESR(적혈구 침강속도) > 50 mm/h로 현저히 상승. CRP(C-반응 단백질)도 크게 상승하여 다른 갑상선 질환과 구별되는 핵심 단서입니다.

## LAB · 02

### 갑상선 기능 (TSH·FT4)

중독기에 TSH 억제, FT4/FT3 상승. TRAb(자가항체) 음성으로 그레이브스병을 배제하고, Anti-TPO도 대개 음성입니다.

## IMAGING · 03

### 방사성요오드 섭취율 (RAIU)

2~5% 미만으로 거의 측정 불가 수준 — 그레이브스병(>35%)과 구별되는 핵심 소견입니다. 갑상선 세포 파괴를 직접 반영합니다.

## IMAGING · 04

### 갑상선 초음파 (Ultrasound)

경계 불명확한 저에코 영역, 도플러상 혈류 감소. 악성종양과 비슷해 보일 수 있어 회복 후 추적 초음파를 권장합니다.



# 비슷한 질환과 어떻게 구별하나요?

통증 유무·ESR/CRP·RAIU 섭취율이 그레이브스병/하시모토 갑상선염과의 핵심 감별점입니다

## ! 아급성 갑상선염 (de Quervain's)

- 심한 경부 통증 (96%) — 핵심 단서
- ESR/CRP 현저히 상승
- TRAb 음성 · Anti-TPO 음성
- RAIU 매우 낮음 (< 5%)
- 초음파 혈류 감소
- 치료 — NSAIDs / 스테로이드

## + 그레이브스병 / 하시모토 갑상선염

- + 통증 없음 (Graves'-Hashimoto 모두)
- + ESR/CRP 정상
- + Graves' — TRAb 양성 (~95%)
- + Graves' — RAIU 높음 (> 35%)
- + 초음파 혈류 — Graves'에서 현저히 증가
- + 치료 — 항갑상선제(MMI) 또는 경과 관찰

# 치료 1단계 — NSAIDs와 베타차단제

경증~중등도는 NSAIDs로 통증을, 베타차단제로 빈맥·손떨림 등 갑상선중독 증상을 조절합니다

## DRUG · 01 · 1차 선택

### NSAIDs (소염진통제)

이부프로펜 400~800mg 또는 록소프로펜 60mg, 하루 3회. 경증 통증의 1차 약제이며, 위장 보호를 위해 PPI와 병용합니다.

## DRUG · 02 · 심장 증상

### Propranolol (베타차단제)

프로프라놀롤 10~40mg 하루 3회. 빈맥·손떨림·두근거림을 조절하며, 중독기(2~6주) 동안만 복용합니다. 천식 환자는 다른 약제로 대체.

## DRUG · 03 · 위장 보호

### PPI (위장약 병용)

NSAIDs 장기 복용 시 위염·위궤양 예방을 위해 오메프라졸·란소프라졸 등을 식전 30분에 함께 복용합니다.

## DRUG · 04 · 효과 평가

### 2~3일 후 재평가

2~3일 복용 후 통증이 호전되지 않으면 스테로이드(프레드니솔론)로 전환합니다. 항갑상선제(MMI/PTU)는 효과가 없습니다.

**중요** 항갑상선제(메티마졸/PTU)는 사용하지 않습니다 — 호르몬이 새로 합성되는 것이 아니라, 파괴된 세포에서 저장돼 있던 호르몬이 유출되는 것이기 때문입니다.



# 치료 2단계 — 스테로이드 감량 프로토콜

NSAIDs 효과 부족 시 프레드니솔론 사용 — 천천히 줄여야 재발(약 12%)을 예방할 수 있습니다



**감량 원칙** 5mg까지 줄이는 데 4주 미만이면 재발 위험이 높아집니다 (비재발군 44.3일 vs 재발군 19.0일). 절대 임의로 중단하지 마세요 — 급격한 중단은 부신 위기를 유발할 수 있습니다.



# 반드시 즉시 알려야 할 위험 신호

치료 중 다음 증상이 나타나면 처방을 임의로 조절하지 말고 바로 진료를 받으세요



## 갑상선 폭풍 의심 — 응급 상황

고열(39도 이상)·심한 빈맥(분당 130회 이상)·의식 혼돈·구토가 동반되면 갑상선 폭풍(thyroid storm) 가능성 — 즉시 응급실로 가야 합니다.



## 스테로이드 임의 중단 시 부신 위기

증상이 좋아졌다고 혼자 판단해 끊으면 부신 위기(심한 저혈압·쇼크) 위험. 반드시 의사 지시에 따라 천천히 감량하세요.



## 48~72시간 내 통증 호전 없음

스테로이드 복용 후 2~3일 이내에 통증이 뚜렷이 줄지 않으면 진단이 맞는지 재평가가 필요합니다 — 즉시 재진하세요.



## 영구적 갑상선기능저하증 (5~15%)

회복 후에도 6~12개월간 TSH 정기 검사 필수. 피로·추위 민감·체중 증가가 지속되면 호르몬 보충(레보티록신)이 필요합니다.

# 오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

대부분 완전히 회복됩니다 — 꾸준한 복약·경과 관찰이 회복의 핵심입니다

**01** 바이러스 감염 후 발생하는 **자기 한정적 질환** — 12~18개월 내 85~95% 완전 회복

**02** 목 앞쪽 통증이 핵심 증상 — **그레이브스병과 다름** (그레이브스병은 통증 없음)

**03** 경증 — **NSAIDs(부루펜·록소닌) + PPI(위장약)** 병용

**04** 빈맥·손떨림 — **프로프라놀롤(인데랄)** 로 조절

**05** 중등도~중증 — **프레드니솔론 6~8주 단계 감량** (절대 임의 중단 금지)

**06** 2~3일 내 통증 호전 없으면 **즉시 재진** — 진단 재평가 필요

**07** 갑상선 기능검사(TSH)를 **6~8주 간격** 정기적으로 받기

**08** 피로·추위 민감·체중 증가 등 **기능저하 증상** 나타나면 알리기

# 함께 치료하면 반드시 회복됩니다

궁금한 점이 있으시면 언제든지 상담해 주세요 — 정기 검사로 끝까지 함께하겠습니다

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30  
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요